جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نرمين خليفه محمد خليفه
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** بولاق الدكرور **العنوان :** 00
رقم البطاقة : 28207278800368 **رقم التليفون :** 01223309340 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 27-07-1982 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي تاكسان (دوسيتاكل) [14152] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نرمين خليفه محمد خليفه
National ID: 28207278800368

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Docetaxel chemotherapy**
إجمالي الجرعات المعتمدة بالقرارات السابقة: 8 (جرعه)، المستلم منها: 5، والمتبقي: 3.

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

كود المستشفى: 102233

وزارة الصحة و السكان
الامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة
جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

فاتورة علاج رقم ٢٢٥٥٥٣٤٢

تقر مستشفى جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * بأن أصول مستندات الصرف ومؤيداتها القانونية صحيحة وعلى مسئوليتنا.
وتم حفظها بغرفة الحفظ لدينا وتحت تصرف الجهاز المركزي للمحاسبات واننا لم ولن نتقدم بتلك الفاتورة لأي جهة اخرى للصرف.

اسم المريض نرمين خليفه محمد خليفه الرقم القومي ٢٨٢٠٧٢٧٨٨٠٠٣٦٨
قرار وزاري رقم ٢٠٢٦٤٠٧٤٧٤٢٩ بتاريخ ١٣-٠٨-٢٠٢٦ بمبلغ ١٦٢١١ مدة القرار ٩٠ يوم
تاريخ الفاتورة ١٩-٠٨-٢٠٢٦ التشخيص سرطان بالثدي (مبادرة)
الإجراء علاج كيماوي تاكسان (دوسيتاكل) 4 جرعات (شامل المتابعه والتحاليل) الخصم (%) ٠

مدين	بيان	كمية	وحدة	تاريخ الصرف	ملاحظات
٢٢.٢٠	NORMAL SALINE 3% 500ml	1	bottel	19/08/2026	
٣٦٠٠	Carboplatin 150 mg / 15 ml	4	vial	19/08/2026	1.5
٨.٦٧	Dexamethasone sod. PO4 8mg	1	AMP / 2 ML	19/08/2026	
٢٥١٨	Docetaxel 80 mg	2	vial	19/08/2026	
٥.٢٤	Chlorpheniramine 5mg Injection	1	ampoule	19/08/2026	
٢٥.١٩	Glucose 5 % Solution	1	Bottle 500 ml WITH rubber cap	19/08/2026	
٤٢٣	filgrastim 300 mg/ml	1	vial	19/08/2026	
٦٥	Granisetron 3 mg	1	اخرى	19/08/2026	
١٧٦	Ondansetron 8 mg	10	Amp 1	19/08/2026	
٢١.٢٨	Pantoprazole 40 mg	14	tablet	19/08/2026	
٢٥	dexamethasone 8 mg	10	tablet	19/08/2026	
٦٨٨٩.٥٨	الاجمالـــــــــي				

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الموظف المختص: يحيي محمد
المراجع: ساره السيد
رئيس حسابات المرضى: عبدالله محمود
مدير الشئون المالية

GRI-E جوستاف روسي مصر

كود المستشفى: 102233

وزارة الصحة و السكان
الامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة
جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

فاتورة علاج رقم ٢٢٩٢٣٠٢٧

تقر مستشفى جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * بأن أصول مستندات الصرف ومؤيداتها القانونية صحيحة وعلى مسئوليتنا.
وتم حفظها بغرفة الحفظ لدينا وتحت تصرف الجهاز المركزي للمحاسبات واننا لم ولن نتقدم بتلك الفاتورة لأي جهة اخرى للصرف.

اسم المريض نرمين خليفه محمد خليفه الرقم القومي ٢٨٢٠٧٢٧٨٨٠٠٣٦٨
قرار وزاري رقم ٢٠٢٦٤٠٧٤٧٤٢٩ بتاريخ ١٣-٠٨-٢٠٢٦ بمبلغ ١٦٢١١ مدة القرار ٩٠ يوم
تاريخ الفاتورة ١٥-٠٩-٢٠٢٦ التشخيص سرطان بالثدي (مبادرة)
الإجراء علاج كيماوي تاكسان (دوسيتاكل) 4 جرعات (شامل المتابعه والتحاليل) الخصم (%) ٠

مـــدين	بيـــــــان	كميـــــــة	وحـــــــدة	تاريخ الصـــــرف	ملاحظـــــــات
١٧٢٠	Docetaxel 80 mg	2	vial	09/09/2026	
٦٥	Granisetron 3 mg	1	اخرى	09/09/2026	
٥.٢٤	Chlorpheniramine 5mg Injection	1	ampoule	09/09/2026	
٢١.٢٨	Pantoprazole 40 mg	14	tablet	09/09/2026	
٢٠.٩٠	Glucose 5 % Solution	1	Bottle 500 ml WITH rubber cap	09/09/2026	250
١٧٦	Ondansetron 8 mg	10	Amp 1	09/09/2026	
٨.٦٧	Dexamethasone sod. PO4 8mg	1	AMP / 2 ML	09/09/2026	
٥٠	Glucose 5 % Solution	2	Bottle 500 ml WITH rubber cap	09/09/2026	
٢٧٠٠	Carboplatin 150 mg / 15 ml	3	vial	09/09/2026	
٤٧٦٧.٠٩	الاجمالـــــــــي				

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الموظف المختص يحيي محمد
المراجع ساره السيد
رئيس حسابات المرضى عبدالله محمود

مدير الشئون المالية
GRI-E
جوستاف روسي
جوستاف روسي مصر

السيد/ مدير عام المجالس الطبيه

تحيه طيبه وبعد ؛؛

مقدم لسيادتكم كشف حساب

بيان بمدفوعات المريض / نرمين خليفه محمد خليفه

الرقم القومي / 28207278800368

عن الفترة من 2026-10-10 **إلى** 2026-10-10

التاريخ	البيان	القيمة
8/19/2026 1:22:20 PM	فاتورة رقم 22555342	6889.58 جنيه
9/15/2026 12:23:51 PM	فاتورة رقم 22923027	4767.09 جنيه
2026-10-10	قيمة صرف لم تتم فوترتها بعد (قرار 202640747429)	4537.12 جنيه
الإجمالي	**16193.79 جنيه**	





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Name : Nermin Khalifa Mohammed Khalifa
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egyp

Date : 13-06-2026 09:59
Medical No. : 392461

$Tc^{99}m$ MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

44 year-old female patient , presented with history of left breast cancer, complains of bony ache and referred for skeletal survey.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mci of the tracer.

Findings

- Uneven radiotracer uptake is noticed at the left high occipital region of the skull.
- Degenerative changes are noticed at different levels of the spine and around big joints.
- Otherwise rest of the scanned skeleton is unremarkable.

IMPRESSION

- Uneven osseous lesion at the left high occipital region of the skull warranting CT correlation to clarify its nature.
- Rest of the scanned skeleton is unremarkable.

Much obliged
Dr. Alaa Nagy, MD
Nuclear medicine

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Name: نرمين خليفه محمد خليفه	
MR. : 10434	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The multidisciplinary team (MDT) discussed the need for a Portacath insertion, bone scan, and contrast-enhanced spectral mammography (CESM). The plan included clipping if the disease was unifocal, followed by neoadjuvant chemotherapy (NACT) with the TCHP regimen for six cycles, and subsequently left wide-local excision (WLE) with sentinel lymph node biopsy (SLNB). Approval for these steps was sent.

The patient was evaluated for left breast cancer, clinical stage T2, with no metastatic disease. Two clips were placed. Pathology showed invasive ductal carcinoma (IDC) grade 2, estrogen-receptor (ER) 7/8 positive, progesterone-receptor (PR) 0/8 negative, HER2 3+ positive, and Ki-67 40 %. Imaging revealed a free breast-surgical margin but an uneven osseous lesion in the left high occipital region of the skull pending CT correlation. CESM identified a retro-areolar mass measuring 2.6 × 2.4 × 2.2 cm and an upper central lesion 3 × 4 mm. The patient received cycle 1 of neoadjuvant therapy with taxotere 150 mg, carboplatin AUC 5, and one dose of prophylactic Neupogen; weight 91 kg, height 172 cm.

On examination, a left retro-areolar mass measured 2 × 2 cm with no palpable axillary lymph nodes. The patient received cycle 2 of taxotere 105 mg (10 % dose reduction) and carboplatin AUC 5, plus prophylactic Neupogen due to grade 3 diarrhea and grade 2 oral mucositis. A CT of the skull was pending for approval of Phesgo.

For cycle 3, the patient was scheduled to receive taxotere and carboplatin AUC 5. Laboratory work was ordered and approval for Phesgo was requested; a CT brain was also requested to correlate with the occipital osseous lesion noted on bone scan. The CT brain was reported as free, and the hematology-oncology team re-requested Phesgo approval.

The patient continued on cycle 3 with taxotere 105 mg, carboplatin AUC 5, and one dose of prophylactic Neupogen. Vomiting improved, and diarrhea showed partial improvement. Approval for Phesgo remained pending.

The MDT reiterated the plan for Portacath insertion, bone scan, and CESM, with clipping if unifocal disease and initiation of NACT (TCHP × 6 cycles) followed by left WLE and SLNB. The most recent assessment documented an ejection fraction of 65 % and indicated that the patient has completed cycle 4 of taxotere/carboplatin and cycle 1 of Phesgo.

تحريرا في ,

التاريخ :	18-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND BECHON SUPPORT

تاريخ الاصدار :2023-2-8

جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التامينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) نرمين خليفه محمد بطاقة رقم 28207278800368

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع بعذر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحي صدر هذا الخطاب دون اى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :2023-2-8

الموظف المختص

اعتماد محمد

افادة مركز نظم المعلومات

يعتمد...

مسلسل 420620

الخطاب ساري لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية او وزارة التضامن الاجتماعى او وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

05/05/2026

MDT FORM

Name:	... ترجمن عليه ... محمد عليه	**MRN:**	10434
Age:	44 Y	**ID:**	28207278800368
Menopausal Status:	POST??	**Phone:**	01223309340
NRS SCORE:		**Marital Status:**	M
BMI:		**Family History:**	- VE
CO Morbidity:		**Reason Of MDT:**	NEW

Clinical Data:

BX: IDC G2

ER: 7 **PR:** 0 **HER2** +3 **KI67:** 40

Sonomammography:

LT BIRADS 4 1-2 O,CLOCK

Mets Workup:

FREE

History:

Heterogeneously dense breasts (ACR c).

Left breast upper central retro-areolar spiculated mass lesion which by ultrasound corresponds to irregular shape hypoechoic solid mass lesion inseparable from the overlying skin seen at 1-2 o'clock para-areolar region measuring about 13x9mm along its maximum dimensions.

Bilateral scattered benign calcifications.

No right breast spiculated masses, clustered microcalcifications or areas of architectural distortion seen.

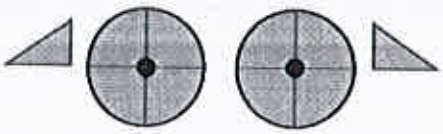
Recommendations:

FOR NACT + THEN BCS + SLNB

MDT Outcome & Plan

For Portacath insertion +bone scan + CESM
Clipping if unifocal and start NACT (TCHP x6 CYCLES)
Then for Lt WLE + SLNB

R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ [illegible]	د/ محمد الترابي				

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

١٠٤٣٤

Patient Name	: الأستاذه / نرمين خليفه محمد خليفه	Request No.	: 13005740
Patient No.	: 28207178800368	Request Date	: 07/04/2026
Path No.	: 905/26	Verification Date	: 21/04/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass, BIRADs 4.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 7/04/2026, at 13:35, Cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:
- Three fragmented grey white tissue cores, ranging in size between 1.0 cm & 1.5 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
* Ductal carcinoma in situ: Absent.
* Perineural invasion: Absent.
* Angioinvasion: Absent.
* Microcalcification: Present.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

USTAVE/
OUSSY
INATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / نرمين خليفه محمد خليفه	Request No.	: 13005740
Patient No.	: 28207178800368	Request Date	: 07/04/2026
Path No.	: 905/26	Verification Date	: 21/04/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جورستاف روسي - مبادره
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass diagnosed "Invasive duct carcinoma grade 2".
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 7/04/2026, at 13:35 , Cold ischemia time: 20 seconds.

Technique:
Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:
IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 7/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67%: 40%.

Conclusion:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

PT:
- ER: Positive (score 7/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 40%.

Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2,

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

USTAVE/
OUSSY
INATIONAL

Patient Name	الأستاذه / ترمين خليفه محمد خليفه	Request No.	13005740
Patient No.	28207178800368	Request Date	07/04/2026
Path No.	905/26	Verification Date	21/04/2026
Sex	Female	Financial Category	جوستاف رومي - مبادره
Age	43 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

ıtermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
Scoring system: "Her2"
teference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining bserved. IHC 0+ (Ultra-low): as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely erceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane taining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
HC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and ıithin >10% of
ıe invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 0% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, ıtense > 10% of tumor cells.

ignature
)r. Walaa Ibrahem Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient's Name:	**nermin khalifa mohamed khalifa**
Date:	**2026-03-25**
Referred by:	Prof.Dr. cap+c
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of CA breast.

I- CHEST:

- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Opinion:

- **No pulmonary or hepatic metastatic lesions.**

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Cairo university –faculty of medicine
Cairo university hospital
Radiology department

جامعة القاهرة -كلية الطب
مستشفيات جامعة القاهرة
قسم الاشعة التشخيصية

Name: ترمين خلينه محمد	**Date: 3/15/2026**
Age: 44 Years	**ID: 28207278800368**

Full Field Digital Mammography With Complementary High Resolution Ultrasound Examination

Indication: *left breast mass.*

Findings:

- Heterogeneously dense breasts (ACR c).
- Left breast upper central retro-areolar spiculated mass lesion which by ultrasound corresponds to irregular shape hypoechoic sold mass lesion inseparable from the overlying skin seen at 1-2 o'clock para-areolar region measuring about 13x9mm along its maximum dimensions.
- Bilateral scattered benign calcifications.
- No right breast spiculated masses, clustered microcalcifications or areas of architectural distortion seen.

Complementary US:

- The right breast parenchyma appears hoeterogeneous with mottled appearance yet with no solid or cystic lesions
- Normal contour and skin thickening of right breast.
- Normal nipple/areola complexes.
- Bilateral small nonspecific axillary lymph nodes with preserved fatty hilum.

Opinion :-

- ***Left breast 1-2 o'clock para-areolar suspicious mass lesion (BIRADS 4), for CESM then histopathology.***
- ***Right mammary adenosis and benign calcifications (BIRADS 1).***

Thanks for referral,

Dr.Eman Badawy, MD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

جوستاف روسي انترناشونال مصر

ECHO REPORT

NAME: تسنيم طلعت عمر

ID NUMBER: 1

DATE: 14/6/2026

SEX:

AGE:

EF	65%	55-75%	PWT	0.8	0.6-1.1cm
LVEDD	4.8	3.5-5.8cm	AO.R	2.1	3-3.7cm
LVESD	2.3	2-4cm	LA	3.5	2-4cm
FS	30%	25-45%	RV		0.7-2.3com(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV Dimensions Normal

LV Wall Thickness Normal

LV Diastolic Function Normal

SWMA No RWMA

LA and Ao Root Dimensions Normal

Mitral Valve

Aortic Valve N

Tricuspid Valve

Pulmonary Valve N

Right Side and Systolic Function TAPSE 2.3

Intracardiac Masses and Effusion

DR.

Echo
[[DOCTYPE:ECHO]]